

Beschreibung der Dissertation

Das Stevens-Johnson-Syndrom bezeichnet eine immunologische Fehlregulation als Reaktion auf verschiedenste Medikamente und Infektionskrankheiten mit oftmals lebensbedrohlichen Symptomen. Nach Antiepileptika und Antibiotika stellen die nichtsteroidalen Antiphlogistika die häufigste Ursache für diese Erkrankung dar. Die Symptome lassen sich in verschiedene Stadien der Progression und des Schweregrades einteilen und umfassen neben primären und sekundären Effloreszenzen auf Haut und Schleimhäuten oftmals auch ein allgemeines Krankheitsgefühl mit Fieber. Die Pathophysiologie ist bislang noch weitestgehend ungeklärt. Es wird von einer fälschlichen Aktivierung der zytotoxischen T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen durch die Interaktion medikamentöser Haptene bzw. Prohaptene mit deren T-Zell-Rezeptoren oder HLA-Molekülen ausgegangen. Auch die Interaktion mit dem Fas-Liganden auf Keratinozyten oder die vermehrte Ausschüttung von Granulysin werden in der Literatur beschrieben. Die aktuelle Studienlage begrenzt sich im Wesentlichen auf Fallberichte und die Forschung nach einem belastbaren Pathomechanismus.

Im Zuge der Dissertation beschäftige ich mich mit der Auswertung von medikamenteninduzierten Stevens-Johnson-Fällen in Form von Spontanmeldungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dabei handelt es sich um eine Sammlung eingescannter Berichtsformulare über unerwünschte Medikamenten-Nebenwirkungen, Arztbriefe, Medikationslisten und Laborberichten. Zu Beginn erfolgt eine umfassende Literaturrecherche zur Erfassung des derzeitigen Kenntnisstandes über das Stevens-Johnson-Syndrom. Drei alltägliche nichtsteroidale Antiphlogistika sollen im Vordergrund stehen: Ibuprofen, Paracetamol und Diclofenac. Zunächst wird eine Übersicht über die Anzahl der Stevens-Johnson Fälle und deren Informationsgehalt erstellt. Die Daten aus diesen Fallberichten werden zur Vorbereitung einer statistischen Auswertung in ein Excel-Format übertragen. Berücksichtigt werden die Symptome, Allgemeinanamnese, Vorerkrankungen, Begleitmedikation, Laborparameter, Biopsien und histologische Untersuchungen der Patienten. Als Kontrollgruppe dienen Spontanmeldungen zu Hautreaktionen und Leberreaktionen auf dieselben drei Antiphlogistika. Mithilfe dieser Datenbank erfolgt die Erkennung gemeinsamer Muster innerhalb der drei Stevens-Johnson-Gruppen, die dem jeweiligen Antiphlogistikum zugeordnet sind. Das Ziel ist die Erkennung von statistisch signifikanten Gemeinsamkeiten innerhalb der aufgeführten Kategorien, welche vor Allem die Symptomatik des Stevens-Johnson-Syndroms betreffen. Des Weiteren sollen die Stevens-Johnson-Fälle mit der Kontrollgruppe verglichen werden, um so belastbare Unterscheidungsmerkmale auf Basis von klinischen Symptomen und Laborparametern herauszuarbeiten. Die statistische Auswertung wird unter Zuhilfenahme des Rucam-Scores erfolgen, um die Wahrscheinlichkeit der Kausalität zwischen Medikamenteneinnahme und Erkrankung zu untersuchen. Aufgrund der bereits im Voraus bekannten Datenlage wird die Erhebung und Auswertung der Daten mit einem unvermeidbaren Bias erfolgen, auf den im Rahmen der Diskussion eingegangen wird.